

С.С. Аширова

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

## Современное состояние и перспективы развития онкологических кабинетов

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 261 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» Правительство Республики Казахстан своим Постановлением от 29.03.2012 года утверждает Программу развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы [1]

Таблица 1 Онкологические кабинеты в РК

| годы | РК  | Акмолинская | Актюбинская | Алматинская | Атырауская | Восточно-Каз. | Жамбылская | Западно-Каз. | Карагандинская | Кызылординская | Костанайская | Мангистауская | Павлодарская | Северо-Каз. | Южно-Каз. | г.Алматы | г.Астана |
|------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2011 | 263 | 18          | 18          | 21          | 7          | 27            | 16         | 17           | 26             | 8              | 22           | 4             | 14           | 17          | 27        | 13       | 8        |
| 2012 | 289 | 18          | 18          | 22          | 7          | 34            | 18         | 18           | 29             | 9              | 25           | 8             | 14           | 17          | 31        | 13       | 8        |

Согласно Этапам реализации Программы в «Направление 4. Развитие и совершенствование инфраструктуры онкологической службы и укрепление ее материально-технической базы» указано довести до утвержденного норматива количество онкологических кабинетов (1 кабинет на 50000 населения, но не менее 1 должности в районных поликлиниках).

В 2013 году планируется открытие 54 онкологических кабинетов, в 2014 году - 27, 2015 году - 20 кабинетов.

Онкологические кабинеты - первичное звено в системе онкологической помощи. Они создаются в составе поликлиники (городской, районной), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических отделений многопрофильной больницы.

Работу онкологические кабинеты строят в соответствии с «Положением о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12.08.2011 года №540. [2]

Онкологические кабинеты (ОК) организуют в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года №238 [3].

В 2011 году по РК функционировало 263 онкологических кабинетов и в 2012 году их стало - 289 (таблица 1).

Как видно из таблицы 1 за год увеличилось число ОК в Восточно-Казахстанской области на 7, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях добавилось по 4, Карагандинской и Костанайской по 3, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях по 2 и 1 онкокабинету.

Базовыми задачами, стоящими перед онкологическими кабинетами (ОК), являются:

- учет больных злокачественными новообразованиями (ЗН), проживающих на территории деятельности кабинета, контроль за своевременным направлением извещений на них в онкологические диспансеры;

- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным ЗН и с подозрением на них;

- диспансерное наблюдение за больными ЗН.

Одной из основных задач ОК является - учет больных со злокачественными новообразованиями.

С целью обеспечения учета больных в ОК и

учреждениях общей лечебной сети, в которых больному впервые был установлен диагноз ЗН, вне зависимости от ведомственной подчиненности указанных медицинских учреждений, заполняется учетная форма «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования» (ф. №90/У) утвержденная приказом Минздрава РК. «Извещение» заполняется на всех больных, которым был установлен диагноз данного ЗН впервые, в том числе:

- на больных, самостоятельно обратившихся в лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью;

- на больных, выявленных при диспансеризации, на профилактических осмотрах, при реализации скрининговых программ;

- на больных, выявленных при медицинском освидетельствовании;

- на больных, выявленных при обследовании и лечении в стационаре медицинского учреждения, в частности, при диагностике ЗН во время оперативного вмешательства;

- на больных, которым был установлен диагноз ЗН на вскрытии («Извещение» в этом случае должно быть заполнено в прозектуре, патологоанатомическом отделении (лаборатории) медицинского учреждения);

- на больных, которым был установлен диагноз ЗН после смерти и информация получена при сверке сведений об умерших от ЗН по данным ЗАГС и статистических управлений со сведениями онкологических учреждений;

- на больных с преинвазивным раком (carcinoma in situ).

«Извещение» должно быть заполнено в день установления диагноза, выслано в онкологическое учреждение регионального уровня по месту постоянного жительства больного в 3-дневный срок с момента заполнения.

Онкологический кабинет осуществляет изъятие дубликатов «Извещения», уточнение и верификацию информации, внесенной в «Извещение». Стадия опухолевого процесса у больных ЗН может быть уточнена с учетом данных, полученных во время хирургического вмешательства, если оно произведено не позднее, чем через два месяца после установления диагноза.

Онкологический кабинет осуществляет контроль за полнотой учета посмертно выявленных заболеваний. Ежемесячно сотрудники ОК должны сверять число

умерших от ЗН, состоявших на учете, с данными отделов ЗАГС.

На умерших от ЗН, не состоявших при жизни на учете в ОК, заполняют «Извещение» с отметкой «Учен посмертно». Кроме того, на всех учтенных посмертно составляется «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования» (ф.№027-2/У).

«Извещение» является основным источником информации при составлении базы данных (БД) Национального канцер-регистра, который формируется в ИАЦ КазНИИОиР и годовых статистических отчетов территориального онкологического учреждения по форме №7 «Отчет о больных и заболеваниях злокачественными новообразованиями».

БД cancer-registra является основным источником для расчетов комплекса аналитических данных по состоянию онкологической ситуации в целом по Республике и отдельно по регионам. Аналитические данные по онкологической службе Республики публикуются в

ежегодном статистическом сборнике института. [4]

## Список литературы

1. Қазақстан Республикасында онкологиялық көмекті дамытудың 2012-2016 жылдарға арналған бағдарламасы. Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы. -Астана, 2012.-90с.
2. Қазақстан Республикасының халқына онкологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы ереже. Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан.- Астана, 2011.- 51с.
3. Приказ №238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №6173).- Астана, 2010.
4. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеусов Д.М., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы).- Алматы, 2012.- 108 с.